Protocolo de identificacion inequívoca del paciente

IDENTIFICACIÓN, OBJETIVO Y APLICABILIDAD

Procedimiento o manual de operación: Protocolo de identificacion inequívoca del paciente. Su finalidad es establecer trazabilidad, responsabilidades y evidencia verificable para la atención segura y la autoevaluación del consultorio.

Aplicabilidad: VERIFICAR EN LA AUTOEVALUACIÓN POR SERVICIO Y MODALIDAD.

Ámbito de uso: atención ambulatoria e infraestructura autorizada en el REPS; adaptar el contenido a las condiciones, recursos, modalidad y cartera de servicios efectivamente declarados.

RESPONSABILIDADES DIFERENCIADAS

01. Responsable técnico: médico/a competente designado/a, sin nombre preimpreso.
02. Apoyo administrativo: custodiar la versión controlada y facilitar registros completos.
03. Prestador: disponer de evidencias reales, gestionar correcciones y verificar habilitación.
04. Usuarios: recibir información suficiente, participar en decisiones y reportar alertas.

RIESGOS PRIORITARIOS DE CONTROL

01. Daño prevenible al paciente: identificar señales tempranas, responsables, barreras preventivas y ruta de reporte.
02. Falla del proceso: identificar señales tempranas, responsables, barreras preventivas y ruta de reporte.
03. Inconsistencia documental: identificar señales tempranas, responsables, barreras preventivas y ruta de reporte.
04. Ausencia de evidencia objetiva: identificar señales tempranas, responsables, barreras preventivas y ruta de reporte.

REFERENTES NORMATIVOS PRINCIPALES

01. Decreto 780 de 2016 (SOGCS y régimen sectorial).
02. Resolución 3100 de 2019 y modificaciones aplicables (habilitación; manual anexo).
03. Resolución 2080 de 2026 (revocó la Resolución 1732 de 2026).
04. Ley 23 de 1981, arts. 15 y 34-36 (ética, consentimiento e historia clínica).
05. Resolución 1995 de 1999 y Resolución 839 de 2017 (historia clínica).

Protocolo de identificacion inequívoca del paciente

SECUENCIA DE APLICACIÓN DEL DOCUMENTO

APERTURA | Verificar que la versión esté vigente, que la actividad pertenezca al alcance autorizado y que el responsable tenga competencia documentada.

IDENTIFICACIÓN | Corroborar sede, usuario o equipo según corresponda; definir fecha, turno, servicio y código del registro.

VALORACIÓN | Identificar riesgos, barreras de seguridad, contraindicación o hallazgo que exige suspender o remitir.

EJECUCIÓN | Aplicar el procedimiento escrito, las instrucciones del fabricante si son pertinentes y los controles específicos de este documento.

CIERRE | Registrar el resultado objetivo, informar hallazgos, entregar recomendaciones y activar seguimiento en caso necesario.

MEJORA | Ante desviación, abrir acción correctiva, responsable, fecha de cierre y evaluación posterior de eficacia.

VERIFICACIONES ESPECÍFICAS PARA ESTA ACTIVIDAD

01. Usar al menos dos identificadores independientes, por ejemplo nombre completo y número de documento; nunca usar número de habitación o apariencia.
02. Confrontar identificadores con historia clínica y orden antes de procedimientos, toma de muestras, prescripción o remisión.
03. Resolver discrepancias antes de atender y documentar su corrección; verificar identidad de representante si procede.
04. Reportar cuasi incidentes de homónimos o registros cruzados y monitorear efectividad de las barreras.
05. Corroborar aplicabilidad al servicio inscrito y a la modalidad real.
06. Asegurar recursos, insumos, responsabilidades y criterios de exclusión.
07. Ejecutar actividad con identificación inequívoca del usuario y registro seguro.

CRITERIOS DE SUSPENSIÓN Y ESCALAMIENTO

Detener la actividad ante ausencia de competencia o autorización, condiciones inseguras, producto o equipo no conforme, negativa del paciente o signos clínicos de gravedad. Documentar la decisión y activar referencia cuando se necesite.

INDICADORES DE CONTROL SUGERIDOS

Cumplimiento documental = registros completos / registros revisados x 100. Incidentes por actividad = incidentes notificados / actividades realizadas x 100. Ajustar metas a línea base y análisis de riesgo.

Protocolo de identificacion inequívoca del paciente

CONTROL OPERATIVO PARA DILIGENCIAR

Sede / consultorio:

Responsable de ejecución (sin prellenar):

Fecha de diligenciamiento y código del caso / equipo:

Actividad verificada, hallazgo y resultado:

LISTA DE VERIFICACIÓN DOCUMENTADA

Verificación	Sí	No	NA	Observación / soporte
Usar al menos dos identificadores i	[ ]	[ ]	[ ]	_____
Confrontar identificadores con hist	[ ]	[ ]	[ ]	_____
Resolver discrepancias antes de ate	[ ]	[ ]	[ ]	_____
Reportar cuasi incidentes de homóni	[ ]	[ ]	[ ]	_____
Corroborar aplicabilidad al servici	[ ]	[ ]	[ ]	_____

HALLAZGOS Y GESTIÓN DE MEJORAS

Hallazgo / desviación identificada:

Acción, responsable y plazo acordado:

Evidencia de cierre / verificación de eficacia:

CONTROL DE VALIDACIÓN INSTITUCIONAL

Elaboró: _____ Revisó: _____ Aprobó: _____

Fecha: _____ Versión: _____ Próxima revisión: _____

Firma del profesional responsable: _____